

Cribado sistémico · Cadera

PhysiQ-Assessment · fase 2. Preguntas literales de la app. Las listas de banderas rojas y amarillas de cada sistema están en la app.

DERIVACIÓN URGENTE · FRACTURA DE ESTRÉS DEL CUELLO FEMORAL

- Puede completarse y comprometer la vascularización de la cabeza femoral. Dolor inguinal vago e insidioso que empeora con la actividad; a menudo el único hallazgo es dolor al final del rango, sobre todo en RI. Dolor profundo nocturno o en carga.
- Perfil: corredor de fondo, militar o deportista de alta intensidad; poca forma al empezar, cambio de superficie o calzado; mujer con tríada de la deportista; corticoides prolongados.
- Percusión rotuliano-púbica (estudiada en fractura de cadera o pelvis tras traumatismo, no en la de estrés; S 85 %, E 70 %, LR+ 2,9, LR- 0,2): supino, fonendoscopio sobre el tubérculo púbico homolateral y percusión de la rótula; positivo si el sonido llega disminuido en el lado doloroso. Talón: golpe con el borde cubital del puño; positivo si reproduce el dolor con la carga axial.
- Una radiografía negativa NO descarta, sobre todo en las primeras semanas. · Adenopatía inguinal sin foco séptico: considerar malignidad. · Sospecha de torsión testicular o de artritis séptica: urgencias hoy.

Posquirúrgico

1. ¿Desde la operación, la herida está más roja, caliente, hinchada o dolorosa, supura o se ha abierto, o ha tenido fiebre, escalofríos o malestar general? **URGENCIA · derivar hoy**
2. ¿Desde la operación tiene una pantorrilla o una pierna hinchada, caliente o dolorosa? (Posible TVP: calcular Wells; ≥ 2 → probable.) **URGENCIA · derivar hoy**
3. ¿Desde la operación tiene una pantorrilla, una pierna o el brazo operado hinchados, calientes o dolorosos? (En la pierna, posible TVP: calcular Wells; ≥ 2 → probable.) **URGENCIA · derivar hoy**
4. ¿Le falta el aire de repente, le duele el pecho al respirar, ha tosido sangre o se ha mareado o desmayado? **URGENCIA · derivar hoy**
5. ¿Desde la operación, o desde que le pusieron un yeso, una férula o un vendaje, tiene un dolor intenso y desproporcionado que va a más, sobre todo al estirar los dedos, con la zona muy tensa, hormigueo o adormecimiento? **URGENCIA · derivar hoy**
6. ¿Tiene un dolor continuo y desproporcionado para la operación, con cambios de color, temperatura, sudoración o hinchazón en la zona, o le duele incluso el roce de la ropa?
7. ¿Desde la operación nota un dolor quemante, hormigueo, adormecimiento o pérdida de fuerza nuevos en la zona de un nervio (por ejemplo, en la mano o el pie del lado operado)? **URGENCIA · derivar hoy**

Cáncer / Oncológico

1. ¿Tiene antecedentes de cáncer de cualquier tipo (especialmente próstata, mama, pulmón, riñón)?
2. ¿El dolor en cadera/muslo es constante, nocturno e intenso, sin posición que lo alivie?
3. ¿Ha notado pérdida de peso rápida e inexplicada, o ha descubierto algún bulto nuevo?
4. ¿Ha notado un ganglio o bulto en la ingle sin una herida, infección o rozadura en esa pierna que lo explique?

Vascular

1. ¿El dolor aparece tras 5-10 minutos de caminar y se alivia casi de inmediato al detenerse (claudicación vascular)?
2. ¿Nota hinchazón, enrojecimiento y calor en la pantorrilla o experimenta calambres nocturnos frecuentes? **URGENCIA · derivar hoy**
3. ¿Experimenta dolor isquémico en la pierna en reposo que mejora al colocarla colgando fuera de la cama?

Urogenital / Renal

1. ¿Ha notado sangre en la orina, ardor o dolor al orinar, o fiebre/escalofríos?
2. (Hombres) ¿Ha notado dolor testicular, secreciones inusuales o dificultad al orinar?
3. (Hombres) ¿Ha empezado de golpe un dolor intenso en un testículo, con hinchazón, náuseas o vómitos? **URGENCIA · derivar hoy**
4. (Mujeres) ¿El dolor de ingle o pelvis se relaciona con la regla, con las relaciones sexuales, o tiene flujo o sangrado inusual?

Gastrointestinal

1. ¿El dolor en la ingle o cadera se acompaña de molestias, distensión abdominal o se alivia al defecar/pasar gases?
2. ¿Ha notado heces negras/alquitrinadas, sangre en las heces o dificultad para limpiarse?
3. ¿Nota un bulto en la ingle, con sensación de peso o de que algo tira, que aumenta al toser o al hacer fuerza?

Óseo / Desarrollo

1. ¿Hace deporte de resistencia o de alta intensidad (o es militar), y el dolor de ingle empezó poco a poco, empeora al cargar peso o al hacer actividad y le duele también de noche? **URGENCIA · derivar hoy**
2. ¿Toma o ha tomado corticoides durante mucho tiempo, bebe alcohol a diario, o tiene lupus u otra enfermedad del tejido conectivo?
3. (Menores de 18 años) ¿Cojea, o el dolor empezó durante el estirón o tras un tirón brusco al chutar, esprintar o saltar?
4. ¿De niño o adolescente tuvo algún problema en las caderas (displasia, Perthes, epifisiolisis)?

Inflamatoria / Infecciosa

1. ¿Tiene fiebre o se encuentra mal en general, con la cadera muy dolorosa o hinchada, hasta el punto de no poder apoyar la pierna? **URGENCIA · derivar hoy**
2. ¿Le duelen o se le hinchán otras articulaciones, o tiene diagnóstico de artritis reumatoide o espondilitis anquilosante?
3. ¿Le han operado de la cadera o la ingle (prótesis, artroscopia, hernia) o le han infiltrado la cadera, y el dolor es nuevo, no cede en reposo o ha tenido una infección reciente?



Endocrino / Metabólico

1. ¿Siente fatiga inusual o debilidad muscular, especialmente al subir escaleras o levantarse de una silla?
2. ¿Ha notado aumento anormal de sed, apetito o frecuencia urinaria (incluso despertándose por la noche)?
3. ¿Ha experimentado cambios recientes en su peso o tolerancia a la temperatura (mucho frío o calor cuando otros no)?
4. ¿Nota que sus heridas sanan muy lentamente o le aparecen moretones con excesiva facilidad?
5. (Si tiene diabetes) ¿Suele tener episodios de bajadas de azúcar, o siente ardor, entumecimiento o pérdida de sensibilidad en manos y pies?



Hematológico

1. ¿Sangra o se le forman moretones fácilmente después de un traumatismo menor, cirugía o procedimiento dental?
2. ¿Experimenta falta de aire, palpitaciones o dolor en el pecho con esfuerzos leves (subir escaleras) o en reposo?
3. ¿Padece infecciones recurrentes o fiebre baja frecuente (resfriados, gripe, infecciones respiratorias)?
4. ¿Ha notado heces negras/alquitranadas, sangre en orina, o ha tosido o vomitado sangre?

Un Sí aislado no implica derivación automática (salvo las preguntas de URGENCIA): evaluar en el contexto clínico completo. Generado desde los datos de la app el 8/10/2026.